2.2013N60 A 女性，62 岁，患高血压病 10 年，2 个月来发作性心悸。心电图诊断为心房颤动，持续 5-24 小时左右自行恢复。4 天前再次发作后持续不缓解来院。查体：BP 125/70mmHg，心率 90 次/分，对该患者正确的治疗措施是

A.立即采取电转复 房颤时间>48h,不能立即转复,此时必须遵循234夹心饼干

B.立即静脉输注胺碘酮转复

C.华法林抗凝 3 周后转复 再抗凝4周

D.经胸 ~~UCG~~ TEE 检查心房内无血栓即可转复

3.2014N59 A 男性，60 岁。因扩张型心肌病，心脏扩大，心功能IV级，心电监测呈现频发室性期前收缩伴短阵阵发性室性心动过速入院治疗。该患者治疗应首选的是 β-R拮抗剂的禁忌症 室早、室速优先考虑:胺碘酮、β-R拮抗剂 利多卡因(次选)

A.静脉输注胺碘酮

B.静脉推注利多卡因

C.静脉推注美托洛尔

D.静脉推注普罗帕酮 禁用于器质性心脏病

4.2015N60 A 男性，47 岁，健康查体发现心房颤动而入院，平素无心悸感，既往体健，无高血压、糖尿病、甲亢病史。超声心动图检查心脏结构正常，化验血脂正常，该患者的最佳处理方案为

A.口服 β 受体拮抗剂

B.临床观察

C.射频消融术

D.口服阿司匹林

5. 2015N93-95 A 女性，75 岁。半年来稍活动后心悸、气短，1 个月来夜间不能平卧，双下肢水肿来院。5 年前患前壁心肌梗死，有高血压病史 16 年，糖尿病史 12 年。查体：T 37.3℃，P 88 次/分，BP 135/60mmHg，半卧位，颈静脉怒张，双肺底可闻及湿啰音，心界向左下扩大，心率 120 次/分，心律不整，$A_2=P_2$，脉短绌，腹壁厚，肝触诊不满意，双下肢凹陷性水肿(++)。全心衰 心衰诱因 NYHA IV级 房颤 陈旧性心梗-NYHA分级

93.目前选用的治疗药物中，不适宜的是

A.噻嗪类利尿剂

B.洋地黄制剂

C.β 受体拮抗剂 NYHA IV级

D.硝酸酯类

94.针对该患者的心律不整，应首选的药物是 先看有无禁忌症 心衰合并房颤用β-R拮抗剂/强心苷

A.普罗帕酮 转复

B.胺碘酮 主要转复也可控心率

C.地高辛 控心率

D.维拉帕米 控心率 有负性肌力作用

若选项中有美托洛尔,且无禁忌症,选美托洛尔还是强心苷?
选美托洛尔 收缩性心衰合并AVNRT或房颤用β-R拮抗剂更好

维拉帕米、普罗帕酮、β-R拮抗剂都有负性肌力作用,只有β-R拮抗剂能用给收缩性心衰(抗重构)

95.实验室检查：血 WBC 12.4×10^9/L，中性粒细胞 82%，ALT 42U/L，血 Cr 264μmol/L，TC 4.21mmol/L，LDL-C 2.96mmol/L，血 K^+ 4.98mmol/L，Na^+ 138mmol/L，血糖 6.5mmol/L。根据检验结果，该患者应调整治疗药物，不恰当的是 感染

A.增加 ACEI 噻嗪类利尿剂改成袢利尿剂:肾小球滤过率<30时

B.改用袢利尿剂 肾功能不好时都可以换(虽然血Cr264GFR没有<30,但是可以换,<30必换)

C.加用抗生素

答案:2-5 C A C CCA